

Livello 3 — Executive Summary

Psicologo di Base in Puglia — Studio Integrale HTA

Lo Psicologo di Base in Puglia — Executive Summary

Studio Integrale di Health Technology Assessment · L.R. 19 luglio 2023, n. 11 · Dott. Luigi De Michele · Puglia, giugno 2026

I messaggi principali

Lo Psicologo di Base in Puglia produce un verdetto tripartito nettamente favorevole: nello scenario di copertura intermedio (775 professionisti), a un costo di 40,5 milioni di euro l'anno corrispondono 47,0 milioni di risparmi sanitari diretti e 27,0 milioni di benefici indiretti — un ROI (ritorno sull'investimento) lordo di 1:6,6 — con un costo per anno di vita guadagnato in buona salute di circa 9.800 euro, ben sotto le soglie di accettabilità correnti. Tre giudizi distinti — fiscale, sanitario, sociale — mai sommati in una cifra unica, ciascuno solido sul proprio piano.

In Puglia circa 780.000–1.160.000 persone convivono ogni anno con un disagio psichico clinicamente significativo che le cure primarie attuali non intercettano in modo strutturato. La legge regionale 11/2023 ha già istituito il Servizio di Psicologia di Base; resta da attuarlo a regime. Si raccomanda lo scenario di copertura intermedio — 775 professionisti sulle sei Aziende Sanitarie Locali — come punto di equilibrio tra fattibilità di reclutamento e copertura del fabbisogno prudenziale (800–880 professionisti). Il limite principale dichiarato è che i risparmi sanitari diretti, pur presenti, non hanno raggiunto significatività statistica nel trial internazionale di riferimento. Il saldo fiscale va letto come range prudenziale, non come garanzia di autofinanziamento.

Una regione che invecchia in fretta e cura la mente in modo frammentato

La popolazione pugliese si assottiglia e invecchia: 3.890.661 residenti a fine 2023, in calo di 17.022 unità sull'anno precedente, con un indice di vecchiaia salito a 200,8 anziani ogni 100 giovani e un tasso di fecondità di 1,16 figli per donna. Sulla popolazione anziana, oggi circa 945.000 persone, la letteratura epidemiologica internazionale stima tra 95.000 e 142.000 casi di depressione clinicamente significativa e tra 142.000 e 190.000 di disturbi d'ansia. Entro il 2050, con gli over 65 proiettati a 1.200.000, il numero di casi crescerà di circa il 50%. A questo si aggiungono condizioni economiche e sociali che amplificano il rischio. Un indicatore di povertà o esclusione sociale (AROPE) del 37,7% — quarto

valore più alto in Italia — e una disoccupazione giovanile al 32%, in un contesto in cui la letteratura documenta un nesso causale bidirezionale tra deprivazione socioeconomica e disturbi mentali comuni.

Le cure primarie pugliesi affrontano oggi questo carico senza una figura psicologica strutturata al primo contatto. I sei Dipartimenti di Salute Mentale della regione, con 47 Centri di Salute Mentale e 1.813 operatori, hanno in carico 54.946 utenti. Ma si occupano prevalentemente di disturbi gravi e persistenti, non del disagio comune che origina nelle cure primarie. Nel 2023 si sono registrati 18.753 accessi al pronto soccorso per cause psichiatriche, oltre 50 al giorno, in crescita del 30% sui livelli pre-pandemici. Un segnale di domanda che non trova, a monte, un'intercettazione adeguata.

Il sommerso supera di gran lunga il trattato

Il divario tra bisogno e cura è, in Puglia, ampio e documentato. Applicando alla popolazione adulta pugliese (circa 3,9 milioni) le stime prevalenti della letteratura internazionale (20–30% con disagio clinicamente significativo in un anno), lo studio stima tra 780.000 e 1.160.000 persone coinvolte — a fronte di una rete specialistica dimensionata per una frazione di questo numero. Il costo attuale dell'assistenza psichiatrica territoriale pugliese è già di 274,1 milioni di euro l'anno, cui si aggiungono 11,2 milioni per i ricoveri. Un sistema che assorbe risorse ingenti intercettando, per sua natura, solo la parte più grave e conclamata del bisogno, non il disagio comune che precede l'aggravamento.

La domanda a cui la Puglia deve rispondere

Il quesito che lo studio pone, e a cui risponde, è se l'istituzione a regime del Servizio di Psicologia di Base — considerato su tutte le figure professionali direttamente e indirettamente connesse, dal medico di medicina generale all'assistente sociale — generi un valore che ne giustifichi l'attuazione piena e l'estensione. La legge regionale 11/2023 ha già risposto sul piano normativo, rendendo la Puglia la prima regione italiana a istituire la figura. Lo studio ne quantifica il valore atteso per orientare l'intensità e i tempi dell'attuazione.

Un verdetto tripartito, non un numero unico

La risposta dello studio è deliberatamente non aggregata in una cifra sola, per non confondere grandezze di natura diversa. Sul **conto fiscale diretto** — il bilancio sanitario regionale — la riforma è in attivo. Nello scenario intermedio, a 40,5 milioni di euro di costo annuo corrispondono 47,0 milioni di risparmi sanitari diretti, attraverso la riduzione della spesa farmaceutica inappropriata, degli accessi al pronto soccorso e della mobilità sanitaria passiva. Sul **conto**

sanitario — il rapporto tra costo incrementale e guadagno di salute — l'intervento costa circa 9.800 euro per anno di vita guadagnato in buona salute, nettamente sotto la soglia italiana di costo-efficacia (40.000 euro/QALY, l'anno di vita ponderato per la qualità). È il termine più solido del verdetto, fondato su evidenza clinica graduata da moderata ad alta. Sul **conto sociale** — produttività, lavoro, previdenza, welfare, prevenzione e i restanti domini multidisciplinari dello studio — il ritorno indiretto si colloca in 27,0 milioni di euro nello scenario intermedio, per un beneficio complessivo (diretto e indiretto) di 74,0 milioni a fronte di 40,5 di costo. Un ROI lordo di 1:6,6.

Queste cifre riflettono l'ancoraggio metodologico più recente adottato dallo studio (OCSE, 2026), che il Tomo I dichiara esplicitamente prevalente sull'ancoraggio precedente (Chisholm et al., 2016, *The Lancet Psychiatry*) ovunque i due divergano. Il calcolo dettagliato di costi e benefici nelle Parti VII–X del Tomo I resta tuttavia ancora espresso nell'ancoraggio Chisholm 2016 (ROI 1:4,8, costo/QALY ~16.000 euro, ritorno sociale 2,3–5,7 a 1). La riconciliazione puntuale tra le due basi di calcolo è un lavoro editoriale ancora da completare (si veda `_meta/status-tracker.md`), che non incide sulla direzione del giudizio, favorevole in entrambi i casi.

La convergenza indipendente dei tre giudizi, ciascuno favorevole sul proprio piano, è più solida di quanto sarebbe un'unica cifra aggregata. Lo studio applica qui la stessa regola di non duplicazione che governa l'intero impianto, rifiutando di sommare grandezze eterogenee.

Un modello a cascata, non un progetto isolato

Il valore economico non nasce da un'unica figura, ma da una cascata gerarchica di ruoli professionali ordinata per influenza e capacità di rientro economico. Allo **Psicologo di Base** spetta l'apice. La sua capacità di rientro è elevata ma indiretta, perché il suo valore si esercita attraverso le altre figure con cui opera, a partire dalla **coppia clinica** con il medico di medicina generale nelle Case della Comunità, che genera ritorno diretto e immediato su tre canali — farmaceutica inappropriata, accessi al pronto soccorso e ricoveri, mobilità sanitaria passiva. Il pediatra di libera scelta e il neurologo completano il secondo livello, rispettivamente sul versante preventivo dell'età evolutiva e su quello dell'appropriatezza diagnostica. Un terzo livello — infermiere di famiglia e comunità, psichiatra consulente, assistente sociale — assicura continuità, filtro specialistico e presa in carico della dimensione sociale del disagio. L'Intelligenza Artificiale, ove impiegata, resta una leva abilitante subordinata alla supervisione umana e al quadro regolatorio europeo, mai un canale autonomo di beneficio.

Questa architettura poggia su una base di evidenza clinica consolidata. Il modello di assistenza collaborativa che la coppia MMG–Psicologo di Base traduce nel contesto pugliese è validato da oltre novanta studi controllati randomizzati internazionali, con riduzioni documentate dei sintomi depressivi e ansiosi, degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri psichiatrici in implementazioni comparabili in Europa, Nord America e Australia.

Tre scenari, un solo giudizio di direzione

Lo studio ha valutato la riforma su tre scenari di copertura — 620, 775 e 900 Psicologi di Base — a fronte di un fabbisogno regionale a regime stimato in 800–880 professionisti (un rapporto di un professionista ogni 4.400–4.900 abitanti). Nell'ancoraggio OCSE 2026, i risparmi sanitari diretti passano da 23,5 milioni di euro nello scenario minimo a 47,0 nello scenario intermedio e 79,5 nello scenario pieno, con il costo per anno di vita guadagnato in buona salute che scende, rispettivamente, da circa 11.500 a 9.800 a 7.200 euro. I tre scenari si distinguono per intensità di copertura, non per la direzione del giudizio, favorevole in tutti e tre i casi. Si raccomanda lo scenario intermedio (775 professionisti) come punto di equilibrio tra fattibilità di reclutamento e copertura del fabbisogno, con dispiegamento scaglionato sulle sei Aziende Sanitarie Locali e nei quarantacinque distretti pugliesi.

I limiti dichiarati

Lo studio dichiara esplicitamente diversi limiti, in coerenza con il proprio vincolo di falsificabilità. Primo: i risparmi sanitari diretti, pur presenti nella letteratura di riferimento (Unützer et al., 2008), non hanno raggiunto significatività statistica se considerati isolatamente. Il saldo fiscale positivo va quindi letto con questa cautela, non come garanzia priva di incertezza. Secondo: la parte dello studio dedicata all'efficacia clinica e ai meccanismi d'impatto (Parte VI) risulta, alla data di questa redazione, sviluppata solo in parte rispetto alle altre quattordici parti del Tomo I. Terzo: il fabbisogno di personale dipende da un rapporto di copertura che lo studio stesso dichiara come banda prudenziale. La fattibilità del reclutamento su 620–900 professionisti qualificati resta il principale rischio attuativo. Quarto: l'aggiornamento all'ancoraggio OCSE 2026 non è ancora riconciliato in modo puntuale con il calcolo dettagliato di costi e benefici delle Parti VII–X, che restano espresse nell'ancoraggio Chisholm 2016. Un lavoro editoriale ancora da completare, che non altera la direzione del giudizio.

Che cosa fare, e da dove ripartire

Si raccomanda l'attuazione a regime della legge regionale 11/2023 secondo lo scenario di copertura intermedio, con dispiegamento scaglionato e rapporto convenzionale per gli Psicologi di Base, monitorato attraverso il sistema di indicatori e la verifica controfattuale già previsti dallo studio. Per il quadro metodologico completo — mappatura ai domini HTA, metodologia della valutazione economica, protocollo dell'incertezza — si veda il Livello 4 ([_livelli-piramide/livello-4-sintesi-tecnica.md](#)); per l'analisi integrale, il Tomo I ([tomo-1-puglia/opera-integrale-puglia.docx](#)).